

Protocolo de alta — Colecistectomía laparoscópica

Servicio de Cirugía General. Seguimiento telefónico del paciente al que se le ha extirpado la vesícula biliar por vía laparoscópica.

Cuidado de la herida

La intervención deja cuatro incisiones: una en el ombligo, por donde se extrae la vesícula, y tres más pequeñas en el lado derecho del abdomen. La del ombligo es la que más molesta y la que más tarda en cerrar.

Mantenga las incisiones limpias y secas cuarenta y ocho horas. A partir de ahí puede ducharse a diario; seque bien el ombligo, que retiene humedad y es el punto donde con más frecuencia aparece una infección superficial. Si le colocaron puntos reabsorbibles no hay que retirarlos: se caen solos entre la segunda y la tercera semana.

Es normal notar los hombros doloridos durante dos o tres días. Es el gas que se usa para insuflar el abdomen irritando el diafragma, no un problema del corazón ni del pulmón; caminar y aplicar calor local lo alivian antes que el reposo.

Medicación

Tras una colecistectomía se suele pautar un antiinflamatorio y un protector gástrico. El antiinflamatorio se retira en cuanto el dolor lo permita.

Medicamento	Dosis	Pauta	Duración	Observaciones
Ibuprofeno	400 mg	cada 12 horas	5 días	Siempre con el estómago lleno
Omeprazol	20 mg	una vez al día	14 días	En ayunas, 30 minutos antes
Acetaminofén	1 g	cada 8 horas	si dolor	Alternativa si el ibuprofeno sienta mal

No tome ibuprofeno por su cuenta más allá de los cinco días pautados. Si el dolor persiste después de ese plazo, la conducta correcta es avisar al equipo, no prolongar el antiinflamatorio.

Signos de alarma

Acuda a urgencias si presenta fiebre superior a 38.5 grados, coloración amarilla de la piel o de la parte blanca de los ojos, orina de color oscuro como el té, heces muy claras o blanquecinas, dolor abdominal intenso en el lado derecho que se irradia a la espalda, o vómitos que le impidan retener líquidos durante más de doce horas.

La ictericia y las heces claras después de una colecistectomía sugieren un cálculo retenido en la vía biliar y no admiten espera hasta la cita de control: son motivo de valoración urgente el mismo día.

Sangrado

Cualquier sangrado activo por una incisión requiere valoración inmediata.

Actividad

Camine desde el primer día. Los paseos cortos y frecuentes alivian el dolor de hombros mejor que el reposo en cama y reducen el riesgo de trombosis.

Evite levantar más de cinco kilos durante tres semanas y los esfuerzos abdominales durante cuatro. Puede conducir cuando el cinturón de seguridad no le moleste sobre el abdomen y pueda frenar de golpe sin dolor, normalmente hacia el séptimo día. La vuelta al trabajo de oficina suele ser posible a la semana; el trabajo físico exige de tres a cuatro semanas.

Dieta

Sin vesícula, la bilis pasa al intestino de forma continua en vez de liberarse de golpe con las comidas. Eso hace que las grasas se digieran peor durante las primeras semanas y explica la mayoría de las molestias digestivas de este posoperatorio.

Durante las dos primeras semanas evite fritos, embutidos, nata, mantequilla, quesos curados, salsas y chocolate. Reparta la comida en cinco tomas pequeñas en lugar de dos grandes. Después vaya reintroduciendo alimentos de uno en uno, dejando dos o tres días entre cada nuevo alimento para identificar cuál le sienta mal si aparecen molestias.

La diarrea leve durante las primeras semanas es frecuente y suele ceder sola. Si persiste más de un mes o le impide hacer vida normal, coménteselo al equipo en la llamada de seguimiento.

Cita de control

La revisión posoperatoria se programa a los tres días del alta en el consultorio indicado en su hoja. Lleve el informe quirúrgico y la lista de medicamentos que esté tomando, incluidos los que tomaba antes de la operación.